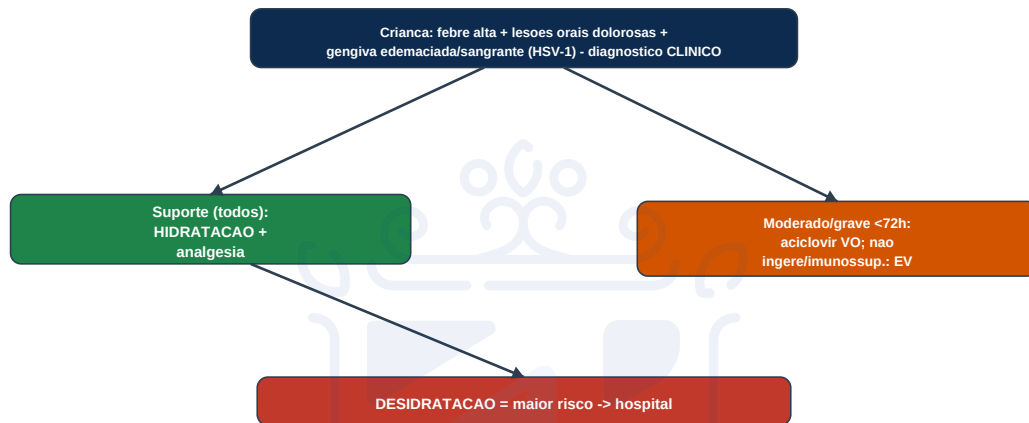


GENGIVOESTOMATITE — HSV-1 + HIDRATAR

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

GENGIVOESTOMATITE — SUPORTE + EVITAR DESIDRATAÇÃO



DEFINIÇÃO E TRANSMISSÃO

PRIMOINFECÇÃO PELO HSV-1

- Manifestação aguda da PRIMOINFECÇÃO pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) em crianças — concentrada na boca
- É a reação inicial e intensa ao primeiro contato com o vírus
- Transmissão por contato direto com secreções infectadas (saliva/gotículas) de quem tem o vírus ativo
- Comum em ambientes com muitas crianças (creches, escolas)
- Faixa etária típica: lactentes e pré-escolares

SINAIS E SINTOMAS

O QUE OBSERVAR

- FEBRE ALTA: quase universal, costuma ser o primeiro sintoma; irritabilidade/choro intenso
- DOR na boca intensa e generalizada -> recusa de comer/beber (mesmo líquidos)
- Lesões orais: múltiplas VESÍCULAS que evoluem para ÚLCERAS dolorosas cobertas por membrana amarelada — em gengivas, língua, palato, mucosa jugal e lábios
- Gengivas: EDEMA, vermelhidão e SANGRAMENTO espontâneo ou ao toque
- Halitose; LINFADENOPATIA cervical e submandibular dolorosa

DIAGNÓSTICO

ESSENCIALMENTE CLÍNICO

- Diagnóstico CLÍNICO: febre alta + lesões orais típicas + gengiva edemaciada, baseado na história e no exame
- Cultura viral/PCR NÃO são de rotina — reservados a casos atípicos, muito graves ou imunossuprimidos
- Diferenciar de estomatite bacteriana e de enterovírus (DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA) para evitar antibiótico desnecessário
- Antibiótico NÃO trata a gengivostomatite (causa viral) — só se houver infecção bacteriana secundária
- Diferencial: herpangina, aftas recorrentes, candidíase, eritema multiforme

TRATAMENTO — SUPORTE É A BASE

Rx HIDRATAÇÃO + ANALGESIA ± ACICLOVIR

HIDRATAÇÃO é a PRIORIDADE: oferecer líquidos (água, sucos diluídos, chás) em pequenas quantidades e com frequência, para prevenir a desidratação

Analgesia/antitérmico: Paracetamol e/ou Ibuprofeno — controlam febre e dor, permitindo a ingestão de líquidos

Cuidados locais (eficácia limitada, sob orientação): lidocaína viscosa ou mistura de Maalox + difenidramina — cautela em crianças pequenas (risco)

ACICLOVIR oral: mais eficaz se iniciado nas primeiras 72h, sobretudo nos quadros moderados/graves; ~15-20 mg/kg/dose, 5-10 dias (prescrição pediátrica) — reduz duração dos sintomas e risco de hospitalização

Aciclovir EV (internação) se a criança não consegue ingerir nada ou é imunossuprimida

Dieta leve/fria/pastosa, evitando alimentos ácidos/duros que pioram a dor

SINAIS DE ALERTA — QUANDO PROCURAR O HOSPITAL

DESIDRATAÇÃO É O MAIOR RISCO

- Sinais de desidratação significativa: boca muito seca, choro SEM lágrimas, redução/escurecimento da urina
- Incapacidade TOTAL de ingerir líquidos por via oral por período prolongado
- Letargia/prostração excessiva (criança muito sonolenta, apática, pouco reativa)
- Sinais de infecção secundária: pus nas lesões, piora súbita da febre/estado geral após melhora inicial
- Criança IMUNOSSUPRIMIDA

INTERNAÇÃO x ALTA E ORIENTAÇÕES

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: desidratação moderada/grave, incapacidade de ingerir líquidos, prostração, infecção secundária, imunossupressão (aciclovir EV)
- ☐ ALTA: criança hidratada, aceitando líquidos, dor/febre controladas, pais orientados
- ☐ Casa: hidratação fracionada rigorosa, analgesia/antitérmico, dieta leve/fria, evitar ácidos
- ☐ Orientar que o quadro é autolimitado (geralmente 7-14 dias) e que o antibiótico não é necessário
- ☐ Retorno IMEDIATO se: recusa total de líquidos, sinais de desidratação, prostração, piora após melhora, pus nas lesões

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Criança ____ anos com gengivostomatite herpética; febre há ____; lesões orais (vesículas/úlceras) + gengiva edemaciada/sangrante; linfadenopatia ____.
- Aceitação de líquidos ____; sinais de desidratação ____; prostração ____; infecção secundária (pus) ____; imunossupressão ____.
- Conduta: hidratação ____ (VO/EV), analgesia (paracetamol/ibuprofeno), cuidados locais; aciclovir ____ (VO < 72h / EV se nãoingere/imunossup.).
- Solicito internação se desidratação/incapacidade de VO/imunossupressão; orientar pais sobre sinais de alarme.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o agente da gengivoestomatite herpética da infância?

- A) Coxsackievírus
- B) Vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) — primoinfecção
- C) Candida albicans
- D) Streptococcus pyogenes
- E) Vírus Epstein-Barr

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a complicação mais importante e o maior risco da gengivoestomatite herpética?

- A) Pneumonia
- B) Desidratação (pela dor que impede a ingestão de líquidos)
- C) Artrite
- D) Otite
- E) Convulsão febril

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Como é feito o diagnóstico da gengivoestomatite herpética?

- A) Sempre por cultura viral
- B) Essencialmente CLÍNICO; cultura/PCR só em casos atípicos, graves ou imunossuprimidos
- C) Por hemocultura
- D) Por biópsia obrigatória
- E) Por sorologia de rotina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quando o aciclovir oral é mais eficaz na gengivoestomatite herpética?

- A) Após 1 semana de sintomas
- B) Quando iniciado nas primeiras 72h, sobretudo em quadros moderados a graves
- C) Apenas em casos leves
- D) Somente por via intravenosa
- E) Não há benefício do aciclovir

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que não se deve prescrever antibiótico de rotina na gengivoestomatite herpética?

- A) Porque a doença é bacteriana
- B) Porque a causa é VIRAL (HSV-1); o antibiótico só se aplica a infecção bacteriana secundária
- C) Porque o antibiótico piora a febre
- D) Porque a doença não tem tratamento
- E) Porque o antibiótico causa desidratação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A gengivoestomatite herpética é a primoinfecção pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) na criança, com lesões orais dolorosas e gengivite.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A desidratação é a complicação mais importante: a dor intensa dificulta a ingestão de líquidos, por isso a hidratação é a prioridade do tratamento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O diagnóstico é essencialmente clínico (febre alta + lesões orais típicas + gengivite); cultura/PCR reservam-se a casos atípicos, graves ou imunossuprimidos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O aciclovir oral é mais eficaz quando iniciado nas primeiras 72h dos sintomas, especialmente nos quadros moderados a graves, reduzindo a duração e o risco de hospitalização.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A causa é viral (HSV-1), sobre a qual o antibiótico não tem efeito; este só é indicado se houver infecção bacteriana secundária (pus, piora após melhora).

SM24
Suporte ao Plantão Médico